

TEMA 1.2 • PEDIATRÍA

Síndrome de Distress Respiratorio del Recién Nacido (SDR)

PERFIL EUNACOM 2.01.1.126

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndrome de Distress Respiratorio del Recién Nacido (SDR)

Generalidades

El **síndrome de distress respiratorio del recién nacido (SDR)** agrupa todas las causas de dificultad respiratoria neonatal. La clínica es inespecífica para todas las causas:

- Taquipnea
- Aleteo nasal
- Quejido espiratorio
- Tiraje / uso de musculatura accesoria
- Desaturación / cianosis

NOTA CLÍNICA

El **diagnóstico** del distress respiratorio es **clínico**. La **radiografía de tórax** es la que orienta a la causa específica.

- **Causas principales:**
- Taquipnea transitoria del RN (TTR)
- Enfermedad de membrana hialina (EMH)
- Síndrome de aspiración meconial (SAM)
- Hipertensión pulmonar persistente del RN (HTPP)
- Neumonía congénita
- Hernia diafragmática congénita
- Cardiopatías congénitas

Tratamiento general (todas): Soporte respiratorio (O₂ en bajo flujo hasta ventilación mecánica) + tratamiento específico según causa.

1. Taquipnea Transitoria del RN (TTR)

Causa: Retraso en la reabsorción del líquido pulmonar fetal.

- **Factores de riesgo:**
- **Cesárea** (sin trabajo de parto, no hay compresión torácica que favorezca la reabsorción)
- **Prematuridad** (< 37 semanas)
- **Clínica:**
- Distress respiratorio **leve**
- Es la causa **más frecuente** de SDR
- Responde bien a **oxígeno en bajas concentraciones**
- Resolución en horas (máximo 1 día)
- **Radiografía:** Normal o pulmón húmedo con:
- **Hilios prominentes**
- **Cisuritis** (derrame en cisura pleural)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Un pulmón húmedo en adulto → insuficiencia cardíaca. El mismo patrón en RN → taquipnea transitoria, de curso **benigno**.

Tratamiento: Oxígeno en bajas dosis. Resolución espontánea.

2. Enfermedad de Membrana Hialina (EMH)

Causa: Déficit de **surfactante pulmonar** → colapso alveolar.

- **Factores de riesgo:**
- **Prematuridad < 34 semanas** (factor principal)
- **Hijo de madre diabética** (puede ocurrir hasta las 35 semanas)
- **Prevención:** Corticoides antenatales (betametasona/dexametasona) maduran los pulmones fetales
- **Clínica:**
- Distress respiratorio **severo**

- En RN **prematureo**
- **Altos requerimientos de oxígeno** (no satura con poco O₂)
- **Radiografía:**
- **Pulmones blancos** (condensación bilateral difusa)
- **Broncograma aéreo**
- Patrón en **vidrio esmerilado** bilateral
- **Tratamiento:**
- Soporte (ventilación mecánica)
- **Surfactante endotraqueal** (tratamiento específico, disponible en sistema público)
- Antibióticos (por sospecha de sobreinfección/neumonía concomitante, no son el tto principal)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Los antibióticos en la EMH son **adjuntos** (por sobreinfección), **NO** el tratamiento principal. El surfactante es lo fundamental.

3. Síndrome de Aspiración Meconial (SAM)

Causa: Aspiración de **meconio espeso/reciente**. El meconio fluido (antiguo) tiene menor riesgo.

- **Factores de riesgo:**
- **Asfixia perinatal** (relaja esfínteres → elimina meconio + el RN jadea → aspira)
- **Postérmino** (> 42 semanas): mayor insuficiencia placentaria y riesgo de asfixia, más meconio acumulado
- **Clínica:**
- Distress respiratorio **severo**
- Componente **obstructivo:** aumento del diámetro torácico, sibilancias
- Antecedente de líquido amniótico meconial (no siempre presente)
- Riesgo de **neumotórax** (por mecanismo valvular del meconio)

Radiografía: Infiltrados bilaterales multifocales (meconio distribuido en distintos segmentos); posible neumotórax.

- **Tratamiento:**
- Soporte respiratorio
- Antibióticos (por riesgo de sobreinfección; meconio = caldo de cultivo)
- **Ante RN con meconio en boca:** aspirar solo orofaringe superficial. NO aspirar profundo (aumenta riesgo de aspiración al inspirar)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No aspirar profundo al ver meconio en boca. La aspiración profunda puede provocar que el RN inspire bruscamente y aspire el meconio.

4. Hipertensión Pulmonar Persistente del RN (HTPP) / Circulación Fetal Persistente

Causa: Hipoxia → vasoconstricción pulmonar → hipertensión pulmonar → más hipoxia (**círculo vicioso**). La circulación fetal (con shunts derecha-izquierda) no se cierra.

- **Factores de riesgo:**
- **Asfixia neonatal** (causa principal)
- Otras causas de SDR (EMH, SAM, neumonía) que generen hipoxia
- **Clínica:**
- Distress respiratorio **severo**
- **Cianosis que NO responde a oxígeno** (igual que cardiopatía congénita cianótica)
- Sin soplo cardíaco (a diferencia de cardiopatías)

TABLA 1.2.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	HTPP	CARDIOPATÍA CONGÉNITA CIANÓTICA
Antecedente de asfixia	Sí	No
Soplo	No	Frecuente
Responde a O ₂	No	No

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante duda con cardiopatía congénita cianótica ducto-dependiente → administrar **prostaglandina E1** para mantener el ductus abierto mientras se estudia.

Radiografía: Normal (o muestra alteraciones de la causa de base: EMH, SAM, etc.)

- **Tratamiento:**
- Reanimación neonatal vigorosa (romper el círculo vicioso)
- **Oxígeno** (es el vasodilatador pulmonar más importante)
- Soporte ventilatorio

Resumen Comparativo

TABLA 1.2.2: CARACTERÍSTICA VS TTR				
CARACTERÍSTICA	TTR	EMH	SAM	HTPP
Severidad	Leve	Severa	Severa	Severa
Factor de riesgo	Cesárea, prematuro	< 34 sem, DM materna	Asfixia, postérmino	Asfixia, hipoxia
Radiografía	Pulmón húmedo, cisuritis	Pulmones blancos, vidrio esmerilado	Infiltrados multifocales	Normal
Tto específico	O ₂ bajo flujo	Surfactante endotraqueal	Soporte	O ₂ , reanimación

| Cianosis sin O₂ | No | No | No | Sí |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Prematuro de 29 semanas desarrolla a las 2h de vida dificultad respiratoria progresiva, quejido, aleteo nasal, cianosis y radiografía con patrón en 'vidrio esmerilado' bilateral con broncograma aéreo. ¿Diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome de Distress Respiratorio del Recién Nacido (SDR). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Generalidades
- 1. Taquipnea Transitoria del RN (TTR)
- 2. Enfermedad de Membrana Hialina (EMH)
- 3. Síndrome de Aspiración Meconial (SAM)
- 4. Hipertensión Pulmonar Persistente del RN (HTPP) / Circulación Fetal Persistente
- síndrome de distress respiratorio del recién nacido
- del distress respiratorio es

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO DEL RECIÉN NACIDO (SDR))**PREGUNTA 1**

Prematuro de 29 semanas desarrolla a las 2h de vida dificultad respiratoria progresiva, quejido, aleteo nasal, cianosis y radiografía con patrón en 'vidrio esmerilado' bilateral con broncograma aéreo. ¿Diagnóstico más probable?

- A)** Neumonía neonatal por *Streptococcus agalactiae*
- B)** Síndrome de aspiración meconial
- C)** Síndrome de distress respiratorio (enfermedad de membrana hialina)
- D)** Taquipnea transitoria del RN
- E)** Neumotórax espontáneo neonatal

PREGUNTA 2

En el manejo del SDR neonatal, ¿cuál es el tratamiento más importante que ha reducido la mortalidad de esta patología?

- A)** Antibioticoterapia profiláctica con ampicilina
- B)** Corticoides prenatales a la madre para maduración pulmonar
- C)** Oxígeno al 100% por mascarilla desde el nacimiento
- D)** Restricción hídrica estricta las primeras 24h
- E)** Diuréticos para reducir el edema pulmonar

PREGUNTA 3

¿A partir de qué edad gestacional se recomienda la profilaxis con corticoides antenatales para prevenir el SDR?

- A)** Desde las 20 semanas de gestación
- B)** 24 a 34 semanas de gestación
- C)** Solo en mayores de 36 semanas con síntomas
- D)** Únicamente cuando ya se diagnosticó SDR postnatal
- E)** No están indicados, el surfactante exógeno es suficiente

RESUMEN: SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO DEL RECIÉN NACIDO (SDR)

El síndrome de distress respiratorio del recién nacido (SDR) agrupa todas las causas de dificultad respiratoria neonatal. La clínica es inespecífica para todas las causas: ::::note El diagnóstico del distress respiratorio es clínico. La radiografía de tórax es la que orienta a la causa específica. ::: Tratamiento general (todas): Soporte respiratorio (O₂ en bajo flujo hasta ventilación mecánica) + tratamiento específico según causa.